

To biologia — *nie* charakter

36 zdrowych mężczyzn, kontrolowane niedożywienie. Reprodukowało wszystkie psychiczne objawy AN — u osób bez historii zaburzenia. Klasyk destygmatyzacji.

CZAS: 15 min psychoedukacji **REALIZACJA:** każdy pacjent + rodzina; destygmatyzacja

ŹRÓDŁO: Keys, Brožek, Henschel, Mickelsen & Taylor (1950, *The Biology of Human Starvation*, University of Minnesota Press, 2 tomy); Kalm & Semba (2005, podsumowanie współczesne)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **opis badania:** kim byli uczestnicy, jakiej procedurze poddano, jak długo trwało. W sekcji 02 — **siedem grup skutków** niedożywienia obserwowanych u zdrowych osób: obsesje, rytuały, nastrój, wycofanie, perfekcjonizm, libido, sztywność. Sekcja 03 — **praktyczne implikacje:** dlaczego refeeding jest warunkiem koniecznym leczenia. Sekcja 04 — co możesz oczekiwać po odżywieniu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Minnesota Starvation Study (Keys i in., 1950) — eksperyment na 36 zdrowych mężczyznach poddanych 24 tygodniom głodzenia. Wyniki: *obsesje jedzeniowe*, rytualizacja, depresja, drażliwość, wycofanie społeczne, sztywność poznawcza, spadek libido — *wszystkie* objawy występujące w AN. **Wniosek kluczowy:** te „objawy psychiczne” są *skutkiem* głodzenia, *nie* przyczyną AN. Bez restauracji wagi terapia poznawcza pracuje na pustym silniku.

01



Opis badania — 36 zdrowych mężczyzn, 24 tygodnie, około 25% utraty masy

Keys i in. (1950): 36 zdrowych, młodych mężczyzn — sumiennych objectors z czasu II wojny światowej — poddano *kontrolowanemu* niedożywieniu przez 24 tygodnie. Spożycie energetyczne zredukowane do ok. połowy normalnego zapotrzebowania. *Wszyscy* stracili około 25% masy. Następnie 20 tygodni rehabilitacji żywieniowej.

Co krytyczne: uczestnicy *nie mieli* wcześniejszej historii zaburzeń odżywiania, depresji, lęku ani innej psychopatologii. Byli zdrowi przed badaniem. Wszystkie obserwowane objawy psychiczne pojawiły się *w wyniku samego niedożywienia*.

02 © Siedem grup skutków u zdrowych osób — to *nie* charakter, to biologia

SKUTEK	CO KONKRETNIE OBSERWOWANO
1 · Obsesje pokarmowe	Myśli o jedzeniu zajmowały do 80% czasu <i>czuwania</i> . Kolekcjonowanie przepisów, godziny analizy książek kucharskich, sny o jedzeniu.
2 · Rytuały jedzeniowe	Wolne jedzenie, krojenie na małe kawałki, dziwne kombinacje, gromadzenie jedzenia, ukrywanie. Niezamierzone — biologia, nie wybór.
3 · Zaburzenia nastroju	Depresja, lęk, drażliwość, gniew, apatia — u 100% uczestników . Nawet u osób stabilnych emocjonalnie przed badaniem.
4 · Wycofanie społeczne	Utrata zainteresowania kontaktami, hobby, polityką, rodziną. Izolacja jako biologiczna konsekwencja niedożywienia.
5 · Szttywność poznawcza	Narastający perfekcjonizm, trudność z podejmowaniem decyzji, obsesja porządkiem, zubożona refleksja, brak elastyczności.
6 · Spadek libido	Całkowita utrata zainteresowania seksualnego. Adaptacyjne — organizm w głodzie wyłącza funkcje reprodukcyjne (oszczędność energii).
7 · Objawy fizyczne	Bradykardia (zwolnienie serca), hipotermia, obrzęki, zanik mięśni, meszek typu <i>lanugo</i> , spadek tempa metabolizmu.

03 ✎ Co możesz oczekiwać po odżywieniu

KTÓRE Z 7 SKUTKÓW ROZPOZNAJĘ U SIEBIE/BLISKIEJ OSOBY

— obsesje, rytuały, nastrój, wycofanie, sztywność, libido, fizyczne; może być kilka

CO PRAWDOPODOBNIIE USTĄPI PO REFEEDINGU

— *stopniowo, w ciągu tygodni-miesięcy: nastrój, sztywność, obsesje, wycofanie; nie ustępują od razu po pierwszym posiłku*

CO POWIEM OSOBIE, KTÓRA MYŚLI „TO MÓJ CHARAKTER”

— *Minnesota Study: te same objawy u 36 zdrowych mężczyzn; biologia, nie wina*

MÓJ PLAN NA CIERPLIWOŚĆ RODZINY I OTOCZENIA

— *jak edukować bliskich, że odbudowa zajmuje miesiące, nie dni*

Klucz: Minnesota Starvation Study (Keys i in., 1950) jest *jednym z najsilniejszych narzędzi destygmatyzacji* w pracy z AN. Pacjent i rodzina rozumieją: „*spadek nastroju, sztywność, obsesje pokarmowe — to objawy niedożywienia, nie twojego charakteru*”. To *nie* jest „brak silnej woli”, „bunt”, „nieodpowiedzialność” — to **przewidywalna reakcja biologiczna** ludzkiego organizmu na chroniczne niedożywienie. Każda osoba — niezależnie od historii psychopatologii — która doświadczy znaczącej restrykcji żywieniowej przez kilka miesięcy, rozwinie tę samą konstelację objawów. To było obserwowane u 36 zdrowych mężczyzn-ochotników. Klinicznie ważne: *nie wyleczy ich żadna psychoterapia* — tylko odżywienie. Stąd priorytet leczenia: *najpierw odżywienie, potem psychoterapia* (osobny handout — neurobiologia AN). Cierpliwość: odbudowa funkcji mózgu po przywróceniu wagi zajmuje *miesiące* (King i in., 2015 — 6 do 12 miesięcy lub dłużej), nie tygodnie. Pacjent waży „dobrze”, ale jego mózg nadal jest w trybie głodu.

△ *Minnesota Study była badaniem ochotniczym w specyficznym kontekście historycznym (II wojna światowa). Z dzisiejszych standardów etycznych byłaby nieakceptowalna. Klinicznie zachowuje fundamentalną wartość — pokazuje biologiczne konsekwencje niedożywienia.*